



REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Apellido / Surname
GIORDANO

Nombre / Name
ANA LAURA

DONANTE: SI

Sexo / Sex **F** Nacionalidad / Nationality **ARGENTINA** Ejemplar **B**

Fecha de nacimiento / Date of birth
07 MAY / MAY 1982

Fecha de emisión / Date of issue
20 FEB / FEB 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry
20 FEB / FEB 2033

FIRMA IDENTIFICADOL SIGNATURE



Documento / Document

29.372.246

Título N° / Of. Ident.

00535907593

8171



62 031274 1 01

Giordano Ana Laura

Plan 2 210 D G

Código de seguridad **142**

Se actualizará en 1:26 ⓘ

osde



RESUMEN DE HISTORIA CLINICA

1era. Visita

Información Personal

Fec. de Nacimiento: 07/05/1982 Edad: 40

Conyuge: ABDALA, Jose Maria

Domicilio: Oscar Smith 2850

Ciudad:

Teléfonos: 2901 538336

E-mail: anag176@hotmail.com

Antecedentes

Personales:

Familiares

Historia Gestacional: Gestas: 0, Partos: 0,

Ciclo Menstrual: Grupo Sanguineo:

Peso: 0.00 Kg Altura: 0.00 IMC: 0.00

Alergias

Medicación Habitual

Antecedentes Ginecológicos

Antecedentes Reproductivos

Seguimiento

23/05/2022 Episodio de Reproducción

Episodio: 22G0100887 Pareja: ABDALA, Jose Maria

Motivo episodio:

CONSULTA POR EVENTUAL PLANES DE FERTILIDAD. ACTUALMENTE 40 AÑOS DE EDAD

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Esta información es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si Ud no es el destinatario arriba indicado, queda informado que la divulgación de esta comunicación está terminantemente prohibida; en caso de haberla recibido por error, háganoslo saber.

Juncal 3490 (C1425AYV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina / Tel.:(54) 11 4834 -1600 / www.pregna.com.ar

REFIERE:

TM : 28-30 DIAS

ADJUNTA:

1. ECO TV: 14/4/22: OD : FOL DE 12 MM , OI CON 6 MICROFOL . UTERO NORMAL

2. PERFIL HORMONAL: 28-6-21: VIT D : 29.2 , SEROLOGIA PARA HIV, HBV, HCV , VDRL : NEGATIVAS

3. PAP19/8/21: NEGATIVO PARA LESION INTRAEPITELIAL ,

4.PERFIL 16-4-22: FSH 8.55, LH: 6,7 , TSH 4,12, ANDROGENOS NORMALES ,

VER * EVOLUCIONES*

Diag Previo:

Diagnóstico: FACTOR FEMENINO

Factor Femenino: Edad,

Plan Terapeutico:

Se explica sintéticamente la necesidad de interconsulta con Genetista para ampliar los siguientes conceptos sintetizados:

Enfermedades monogénicas:

Se explica a la paciente lo que es una enfermedad monogénica, su frecuencia y prevalencia en determinada población, y la posibilidad de detectar su estado portador, y el de su pareja, para evitar la transmisión a su descendencia.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Esta comunicación es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si Ud no es el destinatario arriba indicado, queda informado que la divulgación de esta comunicación está terminantemente prohibida; en caso de haberla recibido por error, háganoslo saber.

Juncal 3490 (C1425AYV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina / Tel.:(54) 11 4834 -1600 / www.pregna.com.ar

PANEL PORTADORES óvulos y semen propio:

Explico el estudio de panel de portadores. Explico que es un estudio que evalúa si los integrantes de una pareja presentan riesgo elevado de transmitir ciertas enfermedades genéticas a la descendencia por presentar el mismo gen con variantes patogénicas. Se explica que el estudio que ofrecemos en Prega evalúa 158 genes (existen otros con distinto número de genes). Que pueden existir variantes patogénicas que no se informen y que si bien son los genes que más frecuentemente generan enfermedades monogénicas hay genes que no están incluidos en el estudio. Además existen variantes patogénicas no incluidas en los genes evaluados, estableciéndose así un riesgo residual de una afección génica en la descendencia. Explico que disminuye pero no anula el riesgo de anomalías genéticas en la descendencia. Explico que luego de realizar el estudio (en caso de realizarlo) se indica consulta con genetista y que existe la posibilidad de que se necesite realizar estudios complementarios. Este estudio no evalúa riesgo de anomalías cromosómicas ni multifactoriales en la descendencia. Se indica toma de ácido fólico.

PGT:

Se explica la posibilidad de realizar una biopsia embrionaria para realizar un estudio genómico y seleccionar embriones con integridad genética, aptos para ser transferidos.

Explico PGS, alcances, limitaciones y alternativas, así como necesidad de criopreservar el/los embriones biopsiados a la espera del resultado. Explico que el método no aumenta la tasa acumulativa de embarazo, pero evita transferir embriones que están destinados a abortar, no implantar o a generar un nacido con anomalías cromosómicas. Explico probabilidad de error del PGS, por error inherente a la técnica, o por mosaicismo (embriones con líneas celulares con distinta información cromosómica). Se explica el riesgo residual que todo estudio genómico tiene en la actualidad, no pudiendo descartar la ocurrencia de falsos negativos.

Explico que la tasa de implantación de un embrión cromosómicamente normal es del 60-70%, y que con el PGS la tasa de aborto disminuye pero no se anula. Explico que si no hay desarrollo embrionario al día 5-6 (estado de blastocisto), no podrá efectuarse el estudio, y también, que si el/los blastocistos biopsiados no son normales puede no haber transferencia embrionaria. De haber más de un embrión normal, se transferirá el de mejor clasificación morfológica. Explico que el PGS no descarta anomalías genéticas o malformaciones de origen multifactorial

Profesional: Michia, María Celeste

23/05/2022

Evolución Médica

Usuario: Van Thillo, German Hora: 20:49

Evolución:

Se les expulsa a ambos las alternativas reproductivas dada la edad reproductiva avanzada de ambos, explicándose de manera sencilla (tendrán además interconsulta con genética) lo siguiente:

EDAD FEMENINA:

Se informa a la paciente acerca del efecto de la edad femenina en el pronóstico reproductivo, explico la declinación folicular gradual con la edad, y cómo esto impacta en los resultados de los tratamientos de reproducción asistida, según lo demuestran nuestras propias estadísticas, y todas las estadísticas reportadas en Registros Nacionales e Internacionales de Reproducción Asistida (RAFA, REDLARA, ICMART).

Explico que un porcentaje elevado de sus ovocitos puede tener aneuploidías, es decir, alteraciones numéricas de sus cromosomas, que impacten negativamente en la reproducción. Esto puede generar una falla de fertilización, de clivaje embrionario o de implantación, así como también un aumento en la probabilidad de tener un aborto espontáneo, o un recién nacido con anomalías genéticas.

Profesional: Van Thillo, German

23/05/2022

Evolución Médica

Usuario: Van Thillo, German Hora: 20:51

Evolución:

SE INDICA COMPLETAR EN CASO DE QUERER VITRIFICAR OVOCITOS DADA LA DISMINUCION DE LA RESERVA OVARICA CONFORME AVANZA LA EDAD, O TERAPEUTICA SDE FERTILIZACION ASISTIDA CON EL OBJETIVO DE LOGRAR UN EMBARAZO AL PRESENTE:

1. ESPERMOGRAMA,
2. CARIOTIPO
3. SEROLOGIAS CON MENOS DE 6 MESES DE ANTIGUEDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA CRIOPRESERVACION, O TTO DE FERTILIDAD
4. CULTIVO VAGINAL/CERVICAL EN CASO DE EMBRIOTRANSFERENCIA PLANEADA

LO PENSARE EN FUNCION DE SUS DECISIONES.

Profesional: Van Thillo, German

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Esta comunicación es para uso exclusivo del destinatario y puede contener información privilegiada y confidencial. Si Ud no es el destinatario arriba indicado, queda informado que la divulgación de esta comunicación está terminantemente prohibida; en caso de haberla recibido por error, háganoslo saber.

Juncal 3490 (C1425AYV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina / Tel.: (54) 11 4834 -1600 / www.pregna.com.ar

Paciente: Giordano Ana
Edad: 39 Años
Fecha: 14 de Abril de 2022
Medico Solicitante: Dra. Peralta.

ECOGRAFIA GINECOLOGICA

UTERO EN A.V.F. ECOESTRUCTURA HOMOGENEA DE FORMA Y TAMAÑO CONSERVADO CON UN DIAMETRO LONGITUDINAL DE 4.0 cm, DIAMETRO A.P. DE 3.3 cm, Y DIAMETRO TRANSVERSO DE 3.0 cm, CERVIX 2.0 cm, SIN LESIONES MIOMETRIALES FOCALIZADAS AL MOMENTO DEL EXAMEN.

ENDOMETRIO EN DISGREGACION.

OVARIO DERECHO DE 2.0 X 1.6 cm, (VOL 3.25 cc) SE APRECIA IMÁGEN DE ASPECTO FOLICULAR DE 12 mm SIN LESIONES ESTRUCTURALES.

OVARIO IZQUIERDO DE 2.6 X 1.8 cm, (VOL 4.03 cc) SE APRECIAN SEIS IMÁGENES DE ASPECTO MICROFOLICULAR SIN LESIONES ESTRUCTURALES.

DOUGLAS LIBRE.

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: ESTUDIO GINECOLOGICO SIN ALTERACIONES.
RECuento DE FOLICULOS ANTRALES SEIS (6).
ESTUDIO REALIZADO SEGUNDO DIA DEL CICLO.


Dra. Peralta Beatriz
M.N. 63471 MM 499

INFORMACION CONFIDENCIAL - SECRETO MEDICO - ALCANCES DEL ART. 156 DEL COD. PENAL



Sanatorio San Jorge
Laboratorio de Análisis Clínicos

Karukinka 267 - Ushuaia - Tierra del Fuego - Tel: (02901) 422635 Int: 106.

E-mail: laboratoriosj@sanatoriosanjorge.com.ar

PACIENTE: GIORDANO, ANA LAURA

39 Años

Documento: DNI 29372246

ORIGEN: AMBULATORIOS

N° ORDEN: 1391938 MEDICO: PERALTA BEATRIZ

Fecha: 16/04/2022 07:29

ENDOCRINOLOGÍA	Resultados	Valores de Referencia
----------------	------------	-----------------------

TIROTROFINA TSH

TSH - Meia - Ultrasensible - Método CMIA 4.12

uU/mL 0.35 a 4.94

Tiroxina libre (T4 L) - Método CMIA 0.94

ng/dL 0.71 a 1.85

LH - Método CMIA 6.7

mU/mL fase folicular: de 1.0 a 18.0
pico ovulatorio: de 24.0 a 105.0
fase lútea: de 0.4 a 20.0

FSH (Hormona Folículo estimulante)

FSH - Método CMIA 8.55

mU/mL fase folicular: 3.03 a 8.08
pico ovulatorio: 2.55 a 16.69
fase lútea: 1.38 a 5.47
post menopausia : 26.72 a 133.41

Prolactina - Método CMIA 11.20

ng/mL de 5.18 a 26.53

TESTOSTERONA SEGUNDA GNERACION

Testosteona plasmática 0.58

ng/ml Hasta 0.52

Atención: cambio de metodología y unidades a partir del 01/09/2013

ENDOCRINOLOGIA ESPECIAL	Resultados	Valores de Referencia
-------------------------	------------	-----------------------

DELTA 4 ANDROSTENEDIONA 1.40

ng/ml 0,30 - 3,30 ng/ml

Estradiol - Método CMIA 72

pg/mL Fase folicular: 21 a 251
Pico ovulatorio: 38 a 649
Fase lútea: 21 a 312
Postmenopáus.: ND hasta 28

Atención: El uso de fármacos que contienen Fulvestrant puede dar resultados falsamente elevados para la metodología utilizada.-

Testosterona Libre 2,50

pg/ml 2,00 - 8,50 pmol/l

Cambio de método y valores de referencia 01/04/2020

17 Hidroxiprogesterona (17OHPg) 0.50

ng/ml Fase folicular: 0.32 a 1.47
Fase lútea: 0.25 a 2.91
post menopausia: 0.19 a 0.71

Resultados verificados y validados en forma electrónica.

Dr. Jose Vicentin
Bioquímico - MP 119

Bioq. Juan Antonio Bustos

Dr. Mauricio Quesada
Bioquímico
MP 91



SANATORIO DE LA
TRINIDAD
PALERMO

Av. Cerviño 4720
(C1425AIN) Bs. As. I Argentina
Tel. 4127.5500/5555
Fax: 4777.1580

Nombre y Apellido: _____

Entidad: _____

Afiliado: _____

Rp.

DNI 29352246

Quiero permanecer en
Bs As a partir del
19/7/22 y por lo
menos 15 días
para vitrificación de
ovocitos para
preservación del
potencial reproductivo

GERMAN VAN THILLO
MÉDICO
M.N.: 87.602 M.P.: 448.452

13/6/22



PRESUPUESTO PROCEDIMIENTO PRESERVACIÓN FERTILIDAD

- 1- Preservación hasta 8 ovocitos: \$ 85.800 + U\$S 920 (ambos valores + IVA)
- 2- A partir del noveno ovocito se cobrará un extra de u\$s 100 cada 4 ovocitos *
- 3- Mantenimiento mensual de ovocitos criopreservados: \$ 2.900.- con débito automático de VISA CRÉDITO o MASTERCARD CRÉDITO **

*** Información importante:** Si usted desea poner un límite en la cantidad de ovocitos a criopreservar, deberá informarlo a su médico tratante previo al inicio del tratamiento.

Incluye:

- Derechos quirúrgicos
- Inducción y recuperación anestésica
- Punción ovárica
- Monitoreo cardiológico
- Congelamiento inicial de ovocitos
- Honorarios equipo médico – (Cardiólogo, Anestésista, instrumentadora, biólogos, médico tratante y su asistente).
- Laboratorio de Fertilidad Asistida de Alta Complejidad
- Material descartable

No incluye:

- Medicación
- Fertilización In Vitro
- Transferencia de ovocitos/embriones criopreservados

** El valor del mantenimiento está sujeto a futuros aumentos.

AL INICIAR EL TRATAMIENTO EL PACIENTE DEBERÁ FIRMAR UN CONSENTIMIENTO INFORMADO

En caso de cancelación del tratamiento:

- Sin punción se facturará el: 10% del total del tratamiento
- Punción sin óvulos: se facturará el: 90% del total del tratamiento

Forma de pago:

- Se deberá abonar el 50% al iniciar el tratamiento y el saldo deberá ser cancelado previo a la aspiración ovocitaria.
- Al día de la punción el presupuesto debe estar cancelado.
- El 50 % abonado no congela el total del presupuesto, solo congela el porcentaje abonado.
 - El procedimiento se puede abonar con depósito o transferencia bancaria en nuestra cuenta corriente, efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA, American Express, Mastercard o Cabal.
 - Para coordinar el pago del tratamiento por favor comunicarse previamente con Cecilia Mogliati (cmogliati@pregna.com.ar) o Celeste Navarro (cnavarro@pregna.com.ar).
 - Los días sábados o feriados no se reciben pagos.

Los valores de este presupuesto tienen validez por los 15 días siguientes a la fecha de emisión.

Ushuaia | 07 de Junio de 2022

REF. PLAN 210 Afiliada N° 62 031274 1 01

SR. GERENTE

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS (OSDE)

PRESENTE

Me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien por su intermedio autorizar la cobertura para realizar el tratamiento de estimulación y extracción de ovocitos, en el CENTRO MEDICO PREGNA especialista en medicina reproductiva, conforme la prescripción médica adjunta extendida por el médico tratante Dr. Van Thillo German, incluyendo honorarios médicos, medicación necesaria para la estimulación y extracción, como la cobertura integral para la crio-conservación de ovocitos extraídos. El procedimiento ordenado responde a la imperiosa necesidad de preservar el potencial reproductivo y su inicio por razones cíclicas esta previsto para el día 19/07/2022.

Es de destacar que dicha solicitud la hago amparada en el derecho a la salud, y en la especie el de la salud reproductiva, contemplados por la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la CIDDHH, de nuestra Corte Suprema de la Nación, así como por leyes de orden público como específicamente lo son la ley 26.862 (Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida) y su decreto reglamentario n° 956/13.

Por lo expuesto, solicito en un plazo perentorio de no

más de 72 hs. se haga lugar a la autorización de la prestación en los términos solicitados, en el marco normativo señalado, bajo apercibimiento de en caso de silencio o respuesta desfavorable iniciar las acciones legales pertinentes.

Adjunto copia de la historia clínica, certificado médico y presupuesto.

**Ana Laura
Giordano**

Firmado
digitalmente por
Ana Laura Giordano
Fecha: 2022.06.07
00:26:31 -03'00'

De Ana Giordano ★

Asunto **SOLICITA AUTORICE PRESTACIÓN**

A cap-ushuaia-tierradelfuego@osde.com.ar ★

Buenos días, adjunto nota de solicitud de cobertura, con documentación respaldatoria.

Atte.

Ana Laura Giordano

DNI N° 29.372.246

AFILIADA N° 62 031274 1 01

CEL. 2901 - 538336

Asunto **Re: SOLICITA AUTORIZACIÓN PRESTACIÓN**

08/06/2022 01:06 p. m.

A Ana Giordano ★

Estimada Ana Laura, ¡buenas tardes!.

Conforme lo evaluado medicamente por Auditoria, le contamos que cuando la criopreservación tenga como fin el diagnóstico genético preimplantatorio, o bien, cuando el fin sea la maternidad diferida por causas no médicas, OSDE no contempla su cobertura.

Cualquier inquietud, a disposición. Recorte rectangular

Saludo cordial.

Marianela Garrido.

Centro de Atención Personalizada Ushuaia

Gerencia de Atención Personalizada

OSDE - Filial Tierra del Fuego

CAP Ushuaia

San Martín 1055 - (9410) - Tierra del Fuego- Argentina

Tel: (02901) 431606/435051

www.osde.com.ar

INICIA ACCIÓN DE AMPARO

SR. JUEZ FEDERAL

JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

ANA LAURA GIORDANO, D.N.I. N° 29.372.246, por derecho y representación propia, Mat. Fed. T° 502, F° 779, Monotributista Cat. C, domicilio electrónico N° 27-29372246-9, con domicilio real en calle Leandro N Alem N° 2978 casa 2 y constituyendo el procesal en calle 25 de Mayo N° 260 Piso 1° Ofic. 3 de la ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, a V.S. me presento y digo:

I. - OBJETO.-

Que vengo por el presente a iniciar acción de amparo de conformidad con lo establecido por el art. 43 de la Constitución Nacional, y 1° y 4, de la ley 16.986, y ley 26.862 (Acceso integral a los procedimientos y técnicas médicoasistenciales de reproducción médicamente asistida) y su decreto reglamentario n° 956/13, contra **OSDE**, con domicilio real en San Martín N° 1055 de esta ciudad, a fin de que se le ordene brindar, de manera completa e integral, la cobertura de la siguiente prestación: Tratamiento de estimulación y extracción de ovocitos, en el CENTRO MEDICO PREGNA especialista en medicina reproductiva y prestador de la demandada, con fecha de inicio de tratamiento el 19/07/2022, conforme la prescripción médica adjunta extendida por el médico tratante Dr. Van Thillo German, incluyendo honorarios médicos, medicación necesaria para la estimulación y extracción, como la cobertura integral para la crioconservación de ovocitos extraídos, incluyendo protocolo quirúrgico correspondiente al 100% de su costo, acompañante para asistir durante el tratamiento, traslado para ambos desde la ciudad de Ushuaia a la ciudad de Buenos Aires, traslados en la ciudad de Buenos Aires, alojamiento y viáticos, y/o el reintegro de las sumas abonadas por dichos conceptos en caso de que hayan sido erogados con anterioridad al

dictado de la sentencia, todo de conformidad con lo prescripto por el médico tratante y estudios complementarios efectuados.-

Ello es así, habida cuenta que la negativa expresada por la demandada a brindar la prestación indicada, lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad manifiesta de forma actual e inminente, los derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre derechos humanos que la integran (art 75 inc. 22 C.N.), específicamente en lo que respecta al derecho a la salud reproductiva, a la dignidad y a la igualdad.-

Por ello, a V.S. solicito admita favorablemente la presente acción, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 26.862 que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida y su decreto reglamentario n° 956/13 y Ley N° 26682 que establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, en especial en el Art. 7, y así acceder a la cobertura del 100% de del Tratamiento de estimulación y extracción de ovocitos, en el CENTRO MEDICO PREGNA especialista en medicina reproductiva y prestador de la demandada, el que dara inicio el día 19 de julio de 2022, conforme la prescripción médica adjunta extendida por el médico tratante Dr. Van Thillo German, incluyendo honorarios médicos, medicación necesaria para la estimulación y extracción, como la cobertura integral para la crioconservación de ovocitos extraídos, incluyendo protocolo quirúrgico correspondiente al 100% de su costo, acompañante para asistir durante el tratamiento, traslado para ambos desde la ciudad de Ushuaia a la ciudad de Buenos Aires, traslados en la ciudad de Buenos Aires, alojamiento y viáticos, y/o el reintegro de las sumas abonadas por dichos conceptos en caso de que hayan sido erogados con anterioridad al dictado de la sentencia, prestación que se torna necesaria para garantizar mi derecho a la salud reproductiva, a la igualdad y a la dignidad.-

Por último, solicito que la orden se dirija bajo apercibimiento de la responsabilidad personal del representante de **OSDE** en Ushuaia, con aplicación de una sanción conminatoria en el marco de lo dispuesto por el artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación, y de mantener su conducta omisiva pasar las actuaciones al Fuero Penal, a los efectos que correspondan.-

II.-LEGITIMACIÓN - COMPETENCIA.-

II. 1. LEGITIMACIÓN ACTIVA.-

Resultado titular del derecho a la salud reproductiva, a la dignidad e igualdad, afectado por el ilegal accionar de la Empresa de Medicina Prepaga contratada (**OSDE**), por lo cual, me encuentro legitimada en los términos de la Ley N° 16.986 y cc.-

II. 2. LEGITIMACIÓN PASIVA.

Conforme se acredita en autos, resultado afiliada a la empresa de medicina Prepaga **OSDE** afiliación N° **62 031274 1 01** Plan **210**, sobre quien pesa la obligación de cubrir el 100% del Tratamiento de estimulación, extracción y criopreservación de ovocitos indicada por el galeno tratante, a la luz de sus obligaciones legales: Ley 26.862 que garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, su decreto reglamentario N° 956/13 y Ley N° 26682 que establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, Art. 7.

En atención a la afiliación de la suscrita, y a los fines de la efectivización del derecho al "Acceso a la Salud", por cierto, en la mejor calidad posible; derecho humano fundamental, plenamente reconocido y protegido a través de distintos instrumentos comunitarios e internacionales, gozando actualmente de plena jerarquía constitucional en virtud de la expresa recepción en el artículo 75 inc. 22 de nuestra carta magna (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre Art. 11;

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948 Arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales Art 12 inc. 1): “*Los estados Partes en el presente reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental*”; inc. 2 apartado d; Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos Art. 24 inc. 1; Convención Americana de Derechos Humanos Art. 4 inc 1, art. 5 incs. 1, 26), **resulta legitimada pasiva OSDE.-**

II. 3. COMPETENCIA FEDERAL.

La competencia federal surge claramente, toda vez que la demandada se ve comprendida por las previsiones legales que hacen procedente la intervención de la vía de excepción, tal como lo prevé la Ley N° 24.754 que hizo extensivas las prestaciones básicas implementadas por las Leyes N° 23.660, 23.661 y sus reglamentaciones, a las prestadoras privadas de salud, el art 116 de la Constitución Nacional, como así también el art. 2 inc. 6 de la ley 48.-

En consonancia, podemos citar fallos de la CSJN como: “*Kogan, Jonathan c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo*”, Fallos, 328:4095, del 25/11/05, que mantuvo el criterio sostenido in re “*Wraage, Rolando Bernar-doc/ Omint S.A. s/ amparo*”, Fallos, 326:3535, del 16/09/03, oportunidad en la que declaró la competencia del fuero federal, por encontrarse en juego normas y principios institucionales y constitucionales de prioritaria trascendencia para el sistema de salud implementado por el Estado Nacional, Plan Médico Obligatorio, que involucra tanto a obras sociales como prestadoras privadas de servicios médicos, en razón de la Ley N° 24.754 que hizo extensivas las prestaciones básicas implementadas por las Leyes N° 23.660, 23.661 y sus reglamentaciones, a las prestadoras privadas.-

De la primera de las causas mencionadas, vale resaltar la justificación de la competencia federal en la materia por cuanto “*estructura del sistema de salud implementado por el Estado Nacional, que involucra tanto a*

las obras sociales, como a las prestadoras privadas de servicios médicos”.

Por otra parte, y sin perjuicio de la postura que últimamente se ha asumido en cuanto a plantear una controversia de competencia entre la Justicia Federal, y la Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, entiendo que esa cuestión ya ha sido zanjada por un fallo de la C.S.J.N., en un caso similar de la Ciudad de Rio Grande, y sin perjuicio de ello, esa es la postura del Procurador ante la CSJN, mediante su dictamen emitido el **12 de julio del año 2018**, en los autos **FCR6188/2018/3/CS1**, caratulado **“Incidente n° 3 – Actor: “AMPUERO Armando, demandado: “SANCOR SALUD, s/incidente”.**

En definitiva, debe estarse a la tramitación del presente ante la justicia federal, en función también de lo resuelto por la CSJN sobre la competencia en razón de la materia, en los fallos: 340:1660, “P., C”; CSJN 602/2016/CS1; “PINO, Evangelina Magalí c/ ACA Salud s/ Asociación Médica del Departamento Castellano s/ amparo”, sentencia del **27 de febrero de 2018**; entre muchos otros.

Surge en consecuencia, la competencia de V.S. para intervenir en el sub lite.-

III.- HECHOS.-

Que soy afiliada de OSDE N° **62 031274 1 01** Plan **210** desde hace diez años, y en el marco de mi proyecto de vida personal he decidido ser madre.

Que tal como surge del Resumen Clínico adjunto y de mi documentación personal tengo 40 años y mi pareja 47 años, es decir una edad avanzada para concebir.

Así entonces, como primera medida a los fines de avanzar con este proyecto personal coordine con la Dra. Beatriz Peralta, mi ginecóloga de cabecera en Ushuaia, la realización de dos estudios específicos para la determinación del estado de mi reserva ovárico.

Así, la Dra. Peralta en el tercer día de mi ciclo menstrual, mediante una ecografía transvaginal realizó el recuento de folículos antrales, es decir de todas aquellas estructuras foliculares que miden entre 2 y 10 mm.

Complementariamente, me ordenó una serie de estudios hormonales, a partir de los cuales, conjuntamente con el estudio del recuento de folículos darían un panorama de mis posibilidades de concebir en mi avanzada edad.

Una vez obtenidos los resultados, la Dra. Peralta nos informa a mi y a mi pareja que mis estudios eran normales teniendo en cuenta mi edad pero que lógicamente no contaba con mucho tiempo por delante para considerar viable la posibilidad de concretar un embarazo por medios naturales.

Además de la devolución de los resultados de los estudios médicos realizados la Dra. Peralta nos informó respecto del descenso significativo de la capacidad reproductiva a mi edad, es decir la disminución en la cantidad de los ovulos y la baja en la calidad de los mismos, como así también en el caso de lograr la concepción los posibles fallos de implantación de los embriones, y el consecuente aumento de la tasa de abortos espontáneos.

El escenario descripto, sin lugar a dudas nos hizo pensar en tomar con carácter urgente alguna medida que nos permita preservar mi endeble fertilidad.

Luego de comentarle esta decisión a la Dra. Peralta, nos informó que debíamos contactar algun centro especialista en fertilidad de la cartilla de OSDE en Buenos Aires ya que en Ushuaia no se realizan este tipo de procedimientos.

En este estado de cosas, gestionamos un turno virtual con el Dr. German Van Thillo del Intituto PREGNA, prestadores ambos de OSDE.

El día 09 de mayo de 2022 concretamos la consulta con el Dr. Van Thillo, le envíe los resultados de los estudios que había ordenado la Dra. Peralta y efectivamente nos

aconsejó la urgente preservación de mi potencial reproductivo mediante la vitrificación de ovocitos, tal como surge de la orden adjunta.

"La vitrificación es una técnica novedosa de laboratorio que permite congelar estos óvulos sin producirles prácticamente ningún daño, lo que permitirá utilizarlos en el futuro para fertilizarlos e intentar así lograr un embarazo.

En el caso de la preservación de ovocitos se utilizan distintos tipos de esquemas de estimulación ovárica, similares a los utilizados en los tratamientos de Fertilización In Vitro (FIV), con medicación inyectable durante aproximadamente una semana.

La punción y aspiración de los folículos ováricos se realiza en quirófano, bajo sedación, en un procedimiento ambulatorio que le permite a la paciente una rápida recuperación como para volver a su vida habitual a partir del día siguiente.

Los ovocitos recuperados son congelados con la técnica de vitrificación para ser utilizados en el futuro cuando la paciente lo desee.

Cuando esto ocurra los ovocitos criopreservados podrán ser descongelados y fertilizados in vitro (FIV), y los embriones transferidos a la cavidad uterina.

Las posibilidades de éxito con este tratamiento dependen de varios factores tales como el número de ovocitos que lograron criopreservarse y la edad de la paciente al momento de la preservación."
(<https://pregna.com.ar/criopreservacion/>)

Lo transcripto en los párrafos que anteceden fue extraído textualmente de la información que brinda PREGNA al respecto del tratamiento cuya cobertura se pretende.

En fecha 07/06/2022 curse un correo electrónico a la demandada al mail cap-ushuaia-tierradelfuego@osde.com.ar solicitando se autorice dicha prestación adjuntando historia

clínica, prescripción médica y presupuesto vigente.

El día 08/06/2022 recibí la contestación en los siguientes términos: *"Conforme lo evaluado medicamente por Auditoria, le contamos que cuando la criopreservación tenga como fin el diagnóstico genético preimplantatorio, o bien, cuando el fin sea la maternidad diferida por causas no médicas, OSDE no contempla su cobertura."*

En este estado de cosas es que se inicia la presente acción, atento a que limitar la criopreservación a los casos en los que hay diagnóstico genético preimplantatorio y/o el fin sea la maternidad diferida por causas no médicas es ilegítimo y arbitrario.

Esta científicamente probado que la capacidad reproductiva de la mujer desciende de forma significativa a partir de los 35 años, lo que repercute, sobre todo, en la reserva ovárica, tanto en la calidad como en la cantidad de los óvulos.

Además de los problemas que pueden presentarse durante el embarazo y el parto, la edad materna avanzada puede conllevar problemas de fertilidad como fallos de implantación del embrión, lo que aumenta la tasa de abortos espontáneos.

La Ley N° 26.862 de Reproducción Medicamente Asistida en su artículo primero establece que será objeto de la presente ley garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

Por su parte, el artículo segundo define a los efectos de la dicha ley que "se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.

Así, puede advertir VS que en ninguna parte la ley restringe el acceso a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, por el contrario, lo garantiza de manera integral.

En cuanto a la cobertura, el artículo octavo de la ley establece que el sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales INCLUYEN: A LA INDUCCIÓN DE OVULACIÓN; LA ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA; EL DESENCADENAMIENTO DE LA OVULACIÓN; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. QUEDAN INCLUIDOS EN EL PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO) ESTOS PROCEDIMIENTOS, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.

Dicho esto, la limitación que la demandada pretende introducir de manera totalmente ilegítima y arbitraria es inadmisibles.

Continua diciendo la norma que "quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de

guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.

EL SIMPLE HECHO DE TENER MÁS DE 40 AÑOS, PESE A QUE EL RECUENTO HORMONAL Y FOLICULAR SEA BUENO, YA INCLUYE A LA MUJER EN EL GRUPO DE "BAJA RESERVA OVÁRICA".

LA RAZÓN ES MUY SIMPLE: A MAYOR EDAD, LA CALIDAD DE LOS ÓVULOS DECRECE PORQUE AUMENTAN LAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS DEBIDO AL ENVEJECIMIENTO. A MÁS EDAD, PEOR PRONÓSTICO.

A los 20 años, en la cúspide de la fertilidad, las posibilidades de tener un embarazo son del 25% por ciclo, a los 40 años es del 5% por ciclo y a los 45 años del 1% por ciclo.

Es decir, si tenemos a 100 mujeres de entre 40 y 45 años que busquen una gestación, solo lo conseguirán entre 1 a 5 de ellas por cada ciclo.

ESA SOLA RAZÓN POR LA QUE SE VE COMPROMETIDA MI CAPACIDAD DE PROCREAR EN EL FUTURO, HACE NACER MI DERECHO A QUE SE ME GARANTICE EL ACCESO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MÉDICO-ASISTENCIALES DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA.

De lo expuesto surge con meridiana claridad cual es el fundamento de la prescripción médica extendida por el Dr. German Van Thillo, su finalidad y su relevancia, dejando expresamente asentado que de continuar la demandada por la negativa cercena de manera palmaria el derecho de toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud.

Que tal como surge de los considerando del Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.862, el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, reconocido por la Ley N° 26.862, se funda en los derechos a

la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona humana (conforme la Constitución Nacional y los fundamentos y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos), abanico de derechos que se verían seriamente conculcados en caso de no estarse por la porcedencia de la presenta acción.

Así lo ha entendido la jurisprudencia: La Cámara Federal de Paraná, con la mayoría conformada por los jueces Alonso y Busaniche, en autos: "INC. APELACIÓN DE B, MA c/ OBRA SOCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION S/ AMPARO LEY N° 16.986" Expte N° FPA 7540/2016/1/CA1, confirmó la decisión impugnada. Preliminarmente, los jueces tuvieron en cuenta que *"...ante la falta de una respuesta satisfactoria a sus requerimientos médicos, la vía elegida resulta idónea en atención a los intereses en juego, pues, [...] cuando se trata de salvaguardar el derecho fundamental a la salud, la vía del amparo se justifica ampliamente por la naturaleza de los valores que se intentan proteger de modo expedito y eficaz..."*. Asimismo, el tribunal remarcó que *"...la circunstancia de que exista un proyecto de ley con media sanción que regule a futuro la cuestión de los derechos y las relaciones jurídicas derivadas del empleo de las técnicas de reproducción humana asistida, no es óbice para aplicar lisa y llanamente la letra de la ley existente, más aún cuando sabido es que en estas cuestiones, la premura y la urgencia del caso es de prioridad imprescindible y esencial"*. En ese sentido, los jueces consideraron que *"...el tratamiento de extracción y criopreservación, se encuentran dentro de la fase preparatoria para la consecución de un futuro embarazo"*. Asimismo, citaron el decreto reglamentario N° 956/2013 de la Ley de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida en cuanto dispone que *"...prevalecen, entre otros derechos concordantes y preexistentes reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales de rango Constitucional (conforme artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna), los derechos de toda persona a la paternidad / maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud. Que el*

derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, reconocido por la Ley N° 26.862, se funda en los derechos a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona humana...". Por último, los magistrados sostuvieron que "...tanto la ley como su decreto reglamentario consagran el derecho a gozar de la cobertura integral del tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad solicitado, que comprende la criopreservación; que tal procedimiento ya se encuentra incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) (art. 8°, 5to. Párrafo del Decreto 956/2013), y que sin perjuicio de las facultades de la autoridad de Aplicación de elaborar las normas de diagnóstico e indicaciones terapéuticas de medicamentos, procedimientos y técnicas de reproducción asistida para la cobertura por el referido Programa, su ausencia no puede implicar, y por ende justificar de ninguna manera, demora alguna en la aplicación inmediata de las garantías establecidas por la Ley N° 26.862...".

En la causa "D.R.M.P. C/ IOMA S/ AMPARO", el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 de Mar del Plata ordenó a la obra social estatal cubrir la totalidad del tratamiento de fertilidad solicitado por la afiliada.

La demandante presentó estudios médicos, su diagnóstico y el tratamiento prescripto por su médico tratante, quien sugiere la realización de estimulación ovárica controlada para tratamiento de fertilización asistida, constándose la falta de respuesta sin desarrollo folicular ovarico atento la edad reproductiva avanzada.

Argumentó que en el presente caso se encuentran en juego, además del derecho a la salud en sentido amplio, **"el derecho a una buena calidad de vida, a una asistencia médica adecuada, a procrear, a la protección integral de la familia y el derecho a la planificación familiar"**.

La titular del juzgado, Mariana Lucía Tonto, **tuvo en consideración en que la edad de la amparista es determinante para aumentar las chances de lograr un embarazo exitoso. "En el caso de autos la accionante tiene 41 años de edad y una**

reserva disminuída de óvulos, por lo que surge indubitable la urgencia en proveer la cobertura requerida" y la justicia le debe "garantizar la posibilidad de éxito del tratamiento indicado y garantizarle el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales que rodean el presente caso".

La salud reproductiva ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como "el estado general de bienestar físico, mental y social, y no una mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos", adelantó la jueza.

En ese marco, añadió que se debe tener en cuenta que "la imposibilidad de procrear es una deficiencia que puede afectar en forma real y efectiva la calidad de vida, siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de la persona, además de su derecho a procrear".

"Tanto la ley como su decreto reglamentario consagran el derecho a gozar de la cobertura integral del tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad solicitado, que comprende la criopreservación; procedimiento que ya se encuentra incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO)", sostuvo la magistrada.

El peligro en la demora, por su parte, se basó en que la accionante tiene 41 años de edad y una reserva disminuída de óvulos, "por lo que surge indubitable la urgencia en proveer la cobertura requerida -criopreservación de embriones/ovocitos en forma anual-a fin de garantizar la posibilidad de éxito del tratamiento indicado y garantizarle el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales que rodean el presente caso (que han sido detallado en párrafos anteriores), como ser los derechos a procrear, a la protección integral de la familia y el derecho a la planificación familiar"

Por todo lo expuesto, IOMA fue condenada a cubrir el tratamiento requerido que se realizará en una clínica privada de la ciudad de Mar del Plata.

En relación a la criopreservación intentada por la amparista, se encuentra referida en el art. 2º de dicho

decreto que comprende dentro de las técnicas de Alta Complejidad:»... la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la congelación o vitrificación de tejidos reproductivos».

Como se observa es la misma norma y su decreto reglamentario la que fija la cobertura de los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, dentro de los cuales debe entenderse comprendido la guarda de ovocitos, según la mejor tecnología que se disponga (se trata de un proceso de alta complejidad, aún extendida a menores de edad, no exigiendo siquiera el requisito de querer llevar adelante un embarazo, sino que se exige la existencia de problemas de salud o que por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.

Es así donde se sustenta la arbitrariedad manifiesta, puesto que para OSDE la crioconservación de ovocitos en el caso no estaría justificada, porque denuncia que la amparista no tiene ningún problema de salud y justamente el sustento de la sentencia apelada se encuentra por dar por verificada dicha problemática.

Entiendo que la actora se encuentra comprendida dentro de los supuestos establecidos por el art.8 de la mencionada ley por cuanto la prueba adjuntada determina que la misma padece de un cuadro de falla ovárica precoz o reserva ovárica disminuida, conforme a los términos de la pericia y que determina que dicho diagnóstico comprometa su fertilidad, que es justamente lo que la ley pretende preservar frente a problemas de salud evidenciados.

La defensa de la demandada argumentado que dicha problemática no es una afección a la salud, porque no se afecta su fertilidad, contrasta con los términos de la pericia y el informe médico reconocido en autos que como se dijo determina, conforme al transcurso del tiempo, la probabilidad amplia de esterilidad o infertilidad de la amparista, puesto que la capacidad de los ovarios de producir óvulos de calidad se verán afectados con el tiempo.

No nos encontramos con una persona de edad madura

(menopáusica), sino con una amparista que debería encontrarse con una reserva ovárica mayor a la estimada como promedio y que por la afección sufrida padece al día de hoy con la disminución de dicha reserva el compromiso de su salud reproductiva, que es el objeto a resguardar por la referida normativa.

Por consiguiente no estoy de acuerdo con la interpretación que realiza OSDE por la cual considera que dicha criopreservación no se encontraría habilitada en el caso por la ausencia de problemas de salud. La salud reproductiva de la actora se encuentra complicada por dicha disminución de su reserva ovárica, comprometiéndose a futuro no solo en cuanto a la cantidad de óvulos a producir sino también en cuanto a la calidad de dichos óvulos lo que conlleva además a aumentar las probabilidades de sufrir un aborto, evidenciándose el compromiso que la falta de guarda de los óvulos a tiempo puede producir.

Tampoco estoy de acuerdo con la tacha de subjetividad de la experticia por cuanto los puntos de pericia se encuentran satisfactoriamente respondido, sustentados objetivamente en la ciencia médica, con datos certeros (pruebas de laboratorio) que fijan la alteración de los parámetros de normalidad que requieren las hormonas FSH, antimuleriana y prolactina en una mujer joven (34 años de edad) y que se encuentran avalados con el material bibliográfico aportado por la experta (también en «Hormona Anti-Mülleriana (AMH) como marcador de reserva ovárica» - autor/es: PICHON-RIVIERE A.; AUGUSTOVSKI, F; GARCIA MARTÍ, SEBASTIAN; BAR-DACH, ARIEL; GALANTE, J; LOPEZ, A; REGUEIRO, A; GLUJOVSKY, D; ARUJ, PATRICIA; CALCAGNO, JI; LINETZKY, B Revista: Documento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias - IECS - Editorial: IECS, Referencias: Año: 2010 p. 1 - 1 ISSN: 1668-2793, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (www.iecs.org.ar)).

Por otra parte y en ello coincido con la experta, no hay un tratamiento eficaz que pueda tratar a un diagnóstico de baja reserva ovárica y lo que solo existe es la posibilidad que quede embarazada por un técnica de

fecundación in vitro (FIV) con sus propios óvulos o por ovodonación (en forma coincidente: www.reproduccionasistida.org/test-de-reserva-ovarica/, <http://infertilidad.eu/baja-reserva-ovarica>). Coincidiendo también en su conclusión en cuanto que si no se realiza dicha crio preservación de sus propios óvulos tendría afectada su fertilidad y su posibilidad de ser madre.

Dicha pericia resulta coincidente con la afirmación dada por el dr. Sabatini en su declaración de fs.178/9 el cual indica que la crioconservación es necesaria porque «si no guarda óvulos tiene una posibilidad importante de que en el momento en que ella desee buscar un embarazo no pueda ya sea porque no tenga más óvulos o porque sean demasiado pocos lo que quedan».

Adviértase que el razonamiento de OSDE resulta arbitrario, por cuanto indica que: A) «hoy la srta. F. no tiene un problema de fertilidad», cuando observamos que hoy si los tiene (la disminución comprobada de su reserva ovárica determina la cantidad inferior a la normal de los óvulos) y que compromete su fertilidad a futuro (recordando que los óvulos con dicha patología no solo son menos sino de inferior calidad lo que conlleva a la probabilidad de abortos);

B) que resulta una interpretación equivocada de la ley pretender entender que esta indique que la referida criopreservación sea solo como parte integrante de un tratamiento de fertilidad, por cuanto en primer lugar la ley no lo fija, es más se encuentra dispuesta en párrafos distintos lo que determina la independencia de uno y otro, en segundo lugar y de admitir dicha circunstancia (lo que descarto), se estaría condicionando a la amparista, a quedar embarazada cuando se encuentra soltera y sin pareja o someterse a un tratamiento de fertilización (a la sazón con espermodonación) cuando en el día de hoy no lo requiere. Vale decir se está obligando a la amparista a ser hoy madre, como condición para la provisión de prestaciones, cuando la ley solo fija la existencia de algún problema de salud y como hemos venido repitiendo la amparista lo tiene.

Esto conlleva a considerar que al parecer la

demandada pretende hoy realizar la planificación familiar de la amparista, cuando justamente este un derecho exclusivo de la misma y se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la salud. Así se ha dicho que:»La salud genésica significa que la mujer y el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención de la salud que, por ejemplo, permitirán a la mujer pasar sin peligros las etapas de embarazo y parto». (Medina, Graciela, «Tratamiento de fertilización asistida y objeción de conciencia», Publicado en: La Ley Online).

D) También resulta arbitraria la conclusión que la paciente no es infértil y que por ello no necesita crioconservar sus óvulos. Resulta obvio que no padece de infertilidad sino sería imposible requerir la vitrificación/congelación ovocitaria, pero resulta probado que atento a la reducción prematura ovular que conlleva a la mala calidad ovocitaria, seguramente lo será y ello es lo que justifica la referida crioconservación.

En definitiva la crioconservación de los óvulos hoy resulta indispensable para la sra. F. a los fines de «preservar la posibilidad de ser madre en el futuro» (B., M. A. C/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación S/ Amparo Ley 16.986?, Cámara Federal de Paraná, 6/12/2016, «Con gelar los óvulos es un seguro para el futuro», <http://www.diariojudicial.com/nota/77318>).

Analizado el caso sub-examine a la luz tanto de la ley como su decreto reglamentario, que consagra el derecho a gozar de la cobertura integral del tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad solicitado, que comprende la criopreservación; que tal procedimiento ya se encuentra incluido en el Programa Médico Obligatorio (PMO) (art. 8º, 5to. Párrafo del Decreto 956/2013), y que sin perjuicio de las facultades de la autoridad de Aplicación de

elaborar las normas de diagnóstico e indicaciones terapéuticas de medicamentos, procedimientos y técnicas de reproducción asistida para la cobertura por el referido Programa, su ausencia no puede implicar, y por ende justificar de ninguna manera, demora alguna en la aplicación inmediata de las garantías establecidas por la Ley N° 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, hace procedente de manera urgente lo aquí peticionado porque solo así, garantizará el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, reconocido por la Ley N° 26.862, se funda en los derechos a la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona humana, mi derecho a la maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud.

IV. - FUNDAMENTOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO - PRESUPUESTOS SUSTANCIALES PARA LA ACCIÓN DE AMPARO —ARTS. 43 Y 75 INC. 22 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL - DISPOSICIONES DE LA LEY 16.986 Y CC.-

A continuación, se expondrá la configuración, para el caso sub lite, de los requisitos necesarios para la procedencia de la vía procesal que se pretende:

IV. 1.- NEGATIVA EXPRESA OSDE.

La conducta impugnada en el presente caso, resulta ser la NEGATIVA EXPRESA de OSDE a otorgar la cobertura integral y oportuna que, en virtud de la Ley N° 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida y su Decreto Reglamentario N° 956/2013, me debe como su afiliada, restringiendo de manera ilegítima y arbitraria las prestaciones que la normativa referenciada prevé.-

En suma, la Urgencia del caso, no permite perder el tiempo intimando nuevamente a la Prepaga a cumplir con sus

obligaciones legales, y así dar lugar a que continúe haciéndome perder el tiempo con el riesgo que para mi salud reproductiva ello conlleva.

IV. 2.- LESIÓN DE UN DERECHO.

Ha expresado la Corte Suprema de Justicia de La Nación que, *“el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional... y que la vida de los individuos y su protección —en especial el derecho a la salud— constituyen un bien fundamental en si mismo...”* (Fallos: 302:1284; 310:112; 323:1339).

El mismo Tribunal se ha pronunciado en autos “Campodónico de Beviacqua c. Ministerio a Salud y Acción Social” (Fallos: 323:3229, sentencia del 24/10/2000) y “Monteserín, Marcelino c. Estado Nacional” (sentencia del 16/10/2001), reconociendo que a través de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 C.N.), *“ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho de la salud —comprendido dentro del derecho a la vida— y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas”* (Fallos: 321:1684).

Es copiosa la normativa que tutela el Derecho a la Vida y a la Salud:

La Constitución Nacional, en sus artículos 42, 43, y en Tratados que eleva a su misma jerarquía, consagran igualmente estos derechos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre -art. 11-; Declaración Universal de los Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948 -arts. 3, 8 y 25-; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales -art 12 inc. 1): *“Los estados Partes en el presente reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”* ; inc. 2 apartado d-; Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos -art. 24 inc. 1-; Convención Americana de Derechos Humanos art. 4 inc 1, art. 5 incs. 1, 26-.

En cumplimiento de este mandato Constitucional, de tutela prioritaria de la vida y salud de los Seres Humanos, se ha erigido dentro del marco de la Seguridad Social, el Sistema Nacional del Seguro de Salud –regulado por ley 23.661, siendo sus Agentes Naturales las Obras Sociales –reguladas por ley 23.660- y las Empresas de Medicina Prepaga – reguladas por ley 26.682 – debiendo cumplir con el Plan Médico Obligatorio a todos sus afiliados por igual; obligatoriedad que atina al **Principio de Irrenunciabilidad de la Seguridad Social.-**

En este punto, debemos analizar que tanto las obras social como las empresas de Medicina Prepaga, como es el caso de **OSDE**, hacen al Sistema Nacional de Seguro de Salud creado por Ley N° 23.661 *“a efectos de procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica...”* (art. 1 de la ley 23.661) y tiene como objetivo fundamental *“proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud...”* (art. 2 de la ley 23.661 el resaltado, en ambos casos, es agregado).

En esta línea, el Congreso Nacional diseñó específicamente un sistema de prestaciones básicas de atención a cargo de las obras sociales (arts. 1 y 3 de la ley 23.660) y las Empresas de Medicina Prepaga (art. 7 de la Ley 26.682) a favor de sus beneficiarios y afiliados con el objeto de procurar el pleno goce del derecho a la salud sin discriminación alguna, garantizándoles cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (arts. 1 y 2 de la ley 23.661 -el subrayado me pertenece-).

Siendo las obras sociales y las entidades de medicina prepaga (Fallos: 321:1684; 323:1339) quienes deben garantizar ese derecho mediante **acciones positivas**, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento, a la luz de los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), reafirmado el derecho a la presentación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida.-

Asimismo, debe ponderarse:

a) Que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y, en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente-, su persona es inviolable, constituyendo el derecho a la vida un valor fundamental a cuyo respecto los restantes valores siempre tienen carácter instrumental (Corte Suprema, Fallos: 316:479 y 323:1339);

b) Que todas las personas tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental (arts. 42 de la Constitución Nacional y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, ratificado por ley 23.313 -de jerarquía superior a las leyes internas, según el artículo 75, inc.22, de aquélla-).

La accionada, parece olvidar la trascendente función social que está llamada a cumplir, administrándose con una suerte de marcado mercantilismo, procurando evitar el cumplimiento de sus obligaciones, en pos de un rédito económico, y haciendo una suerte de "regateo" con sus afiliados, apostando a la no judicialización de las problemáticas, y el consiguiente ahorro de lo regateado, preocupada en esto, más que el cumplimiento de su función social, el que no resulta ser otro que: **procurar el pleno goce del derecho a la salud sin discriminación alguna brindando una cobertura integral a las necesidades y requerimientos de sus beneficiarios y afiliados** (arts. 1 y 2 de la ley 23.661 y art. 7 de la Ley 26.682).-

IV. 2. 1.- MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO.

Por último, cabe resaltar, el marco Jurídico que me ampara, regulada por la Ley N ° 26.928 de Protección para personas trasplantadas, la que en su parte pertinente transcribo:

ARTICULO 1° - Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida.

ARTICULO 2° - Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación.

ARTICULO 8° - Cobertura. El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a

la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios. También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.

Asimismo, el Decreto Reglamentario N° 956 establece:

ARTICULO 1°.- Objeto. Entiéndase que la garantía establecida por la Ley N° 26.862 tiene por objeto el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, como la posibilidad de acceder a dichos procedimientos y técnicas cualquiera sea la cobertura que posea el titular del derecho. A esos fines, los Prestadores del Servicio de Salud de los ámbitos público, de la Seguridad Social y privado, deberán proveer sus prestaciones respectivas conforme la Ley N° 26.862, la presente reglamentación y demás normas complementarias que al efecto se dicten.

ARTICULO 2°.- Definiciones. Se entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Se consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante. Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos. La Autoridad de

Aplicación resolverá la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas en la cobertura que explicita la Ley N° 26.862, siempre que tales procedimientos y técnicas hayan demostrado eficacia y seguridad con nivel de evidencia A, es decir, a través de ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y luego de la evaluación técnica realizada por la DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, conforme las previsiones del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE CALIDAD DE LA ATENCION MÉDICA. Los mismos serán incorporados por normas complementarias dictadas por el MINISTERIO DE SALUD.

ARTICULO 8°.- Cobertura. Quedan obligados a brindar cobertura en los términos de la presente reglamentación y sus normas complementarias los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcados en las Leyes N° 23.660 y N° 23.661, las Entidades de Medicina Prepaga (Ley N° 26.682), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley N° 19.032), la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, las Obras Sociales Universitarias (Ley N° 24.741), y todos aquellos agentes que brinden servicios médico asistenciales independientemente de la forma jurídica que posean. El sistema de Salud Público cubrirá a todo argentino y a todo habitante que tenga residencia definitiva otorgada por autoridad competente, y que no posea otra cobertura de salud.

En atención a la normativa ut supra enunciada, y a los fines de la efectivización de mi derecho al acceso a la salud, existe, indudablemente, una obligación en cabeza de la demandada, de afrontar los tratamientos, prácticas quirúrgicas, provisión de fármacos, etc., necesarios para garantizar tan trascendente derecho como lo es el derecho a la Salud Reproductiva, como recaudo necesario para garantizar el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, fundado en los derechos a la dignidad, a la

libertad y a la igualdad de toda persona humana, mi derecho a la maternidad y a formar una familia, en íntima conexión con el derecho a la salud y a la vida.

Siendo la **EXPRESA NEGATIVA** de OSDE a cubrir el tratamiento de estimulación y extracción de ovocitos, en el **CENTRO MEDICO PREGNA** especialista en medicina reproductiva y prestador de la demandada, conforme la prescripción médica adjunta extendida por el médico tratante Dr. Van Thillo German, incluyendo honorarios médicos, medicación necesaria para la estimulación y extracción, como la cobertura integral para la crioconservación de ovocitos extraídos indicada, la que con el presente amparo se solicita ordene, consagrando el derecho al acceso a la Salud reproductiva en resguardo del derecho fundamental que es el derecho a la vida.-

IV. 3. - ARBITRARIEDAD MANIFIESTA.

La Arbitrariedad Manifiesta surge del relato mismo de los hechos, expuesto en el punto III del presente, lo que se patentiza en la **Negativa Arbitraria e Ilegal** de parte de OSDE quienes ante el formal requerimiento de cobertura del tratamiento indicado por el médico tratante, no la autoriza, con un fundamento restrictivo, injustificado y en consecuencia improcedente.-

Lo cual, sin necesidad de mayor abundamiento, patentiza la arbitrariedad manifiesta que se necesita para justificar esta vía expedita y rápida, frente a la situación de indefensión que padezco.

IV. 4.- INEXISTENCIA DE VÍA PARALELA.

Actualmente, gran parte de la doctrina se orienta a sostener que el amparo no es un *"último recurso"*, sino que las llamadas *"vías comunes"*, o *"previas"* o *"paralelas"*, son las en virtud de su ineficacia frente a necesidades acuciantes se ven relegadas por el amparo como vía expedita y rápida para la salvaguarda de un derecho constitucional conculcado.-

En lo que no hay mayores discusiones, es en la óptica

con la que debe enfrentarse el amparo con las demás vías disponibles.

Como lúcidamente sintetiza Augusto M. Morello, es necesario realizar un cálculo realista, que ponga en evidencia la razonabilidad de la prescindencia a priori, de un carril que a la postre será claramente ineficaz. En 1969 (*"Régimen Legal y Jurisprudencial del Amparo"*), Germán J. Bidart Campos expresaba, con referencia a la existencia de otros remedios judiciales o administrativos que permitirían obtener la protección del derecho de que se trate (y que obstarían a la admisibilidad del amparo), que ***"no es la existencia de otra vía la que cierra indefectiblemente el amparo, sino la ineptitud de la misma la que lo abre"***.

Por lo tanto, de aceptarse la inexistencia de otro remedio como requisito de admisibilidad del amparo, en el presente caso el mismo se halla configurado. **No existiendo otro remedio judicial, expedito y rápido, que garantice una decisión oportuna de jurisdicción, en resguardo de los derechos fundamentales conculcados.**

A esto se suma, que en la presente cuestión no se requiere extensa producción de prueba, en razón que de la misma documental que se acompaña basta para acreditar la veracidad de mis derechos, dichos y la necesidad imperiosa del tratamiento prescrito, lo que habilita la pretendida vía.- .

VI.- OFRECIMIENTO PROBATORIO.

A efectos de generar certeza sobre la veracidad de cuanto afirmo, **referente a la pretensión de amparo**, solicito se agregue la documental que acompaño, y se ordene la producción de los demás medios probatorios que a continuación detallo:

VI.1. DOCUMENTAL:

A efectos de generar certeza sobre la veracidad de cuanto afirmo, solicito se agregue el siguiente documental:

- Documento Nacional de Identidad
- Credencial de afiliación OSDE N ° **62 031274 1 01.-**
- Resumen Clínico y Certificado Médico expedido por

el Dr. Van Thillo German MN 87.602 MP 448.452 del CENTRO MEDICO PREGNA especialista en medicina reproductiva, indicando vitrificación de ovocitos para preservacion de la fertilidad.-

- Resultados de laboratorio estudios hormonales
- Informe Ecografía de recuento folicular
- Presupuesto de tratamiento extendido por PREGNA.
- Correo electrónico cursado por la actora a OSDE al mail cap-ushuaia-tierradelfuego@osde.com.ar
- Correo electrónico enviado por OSDE desde la casilla de correos cap-ushuaia-tierradelfuego@osde.com.ar a la actora, suscripto por Marianela Garrido, desde el Centro de Atención Personalizada Ushuaia.
- Revistas / NPunto Volumen II. Número 14. Mayo 2019 / INFLUENCIA DE LA EDAD EN LA FERTILIDAD
<https://www.npunto.es/revista/14/influencia-de-la-edad-en-la-fertilidad>

VI.2. INFORMATIVA EN SUBSIDIO:

Para el caso de desconocimiento de la documental adjunta, solicito se sirva oficiar:

- Al CENTRO MEDICO PREGNA especialista en medicina reproductiva a los fines de que se acompañe en autos copia de mi historia clínica y cualquier otra documental que se encuentre en su poder y consideren pertinente al mail cgastaldi@pregna.com.ar y del Presupuesto para la realización del tratamiento de vitrificación de ovocitos actualizado y cualquier otra documental que se encuentre en su poder y consideren pertinente, a Mariangeles: mgomez@pregna.com.ar y/o Celeste: cnavarro@pregna.com.ar y/o Cecilia: cmogliati@pregna.com.ar y/o Maria José: mjsubelza@pregna.com.ar.
- Al Dr. German Van Thillo a los fines de que se expida en relación a la autenticidad de la prescripción médica extendida a la actora, al WhatsApp 11 5000-5011
- A la Dra. Beatriz Peralta a los fines de que

ratifique los hechos y la información médica brindada a la amparista.

VII.- AUTORIZACIONES.

Por la presente se autoriza a los letrados Maria Fernanda Aguirre, Matias Nicolas Vega y Héctor Omar RIVAS, a cotejar el expediente, retirar copias, pericias, cédulas, oficios, etc. y dejar notas. -

VIII.- RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Desde ya, ante la posibilidad de que se resuelva la presente demanda por su rechazo, hago reserva de recurrir por la vía extraordinaria Federal, por causarme gravamen en violación a mis derechos a la salud, a la vida, y al consumo, en los términos de los artículos 42, 43, 75 inciso 22 C.N. y los pactos allí incluidos, doctrina y jurisprudencia aplicable sobre la materia. -

IX. - DERECHO.

Fundo la presente acción en lo dispuesto en la Artículos 42 y 43 de la Ley N° 16.986, Art. 75 inciso 22 y cc. de la Constitución Nacional y los pactos allí reconocidos; Ley N° 26.862 de Reproducción Medicamentosa Asistida y Decreto Reglamentario N° 956, Ley N° 26.682 que establece el régimen de regulación de las empresas de medicina prepaga, en especial el Art. 7°, Ley 23.660 "Obras Sociales", Ley N° 23.661 "Plan Médico Obligatorio", Ley N° 24.754, doctrina y jurisprudencia aplicable sobre la materia. -

X. PETITORIO.

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

- 1- Se me tenga por presentada, parte y constituido domicilio procesal y denunciado el electrónico;
- 2- Se tenga por interpuesta en legal tiempo y forma la demanda;
- 3- Se agregue la documentación adjunta;
- 4- Se tengan presentes los hechos narrados, y el

derecho invocado;

5- Téngase por iniciada acción de amparo;

6- Se corra traslado de la presente demanda, bajo apercibimiento de ley;

8- Se tenga presente, y oportunamente se ordene la producción de la prueba ofrecida de resultar necesaria;

9.- Tenga presente las autorizaciones conferidas;

10.- Se tenga presente la reserva del Caso Federal;

11.- Oportunamente se haga lugar a esta demanda en todas sus partes, condenando a la demandada conforme lo solicitado, con costas.-

**PROVEA DE CONFORMIDAD,
SERÁ JUSTICIA. -**